Protocolo Clínico: Atendimento de Emergência para Dor de Dente Aguda

DOCUMENTO DE TESTE: conteúdo fictício gerado por IA para validar um sistema de busca. Não foi validado por profissional de saúde e não deve ser usado em atendimento real.

Código: PROT-EMERG-DOR-01. Versão 1.0 (fictícia). Público: cirurgiões-dentistas e equipe de apoio. Aplicação: adultos. Para crianças, ver a seção de condições especiais.

1. Objetivo

Padronizar a avaliação e o manejo inicial da dor de dente aguda no atendimento de urgência: aliviar a dor, identificar sinais de gravidade e definir o tratamento definitivo.

2. Sintomas comuns da dor de dente aguda

Pulpite reversível

Dor curta, provocada por frio, calor ou alimentos doces. A dor cessa em poucos segundos depois que o estímulo é removido.

Pulpite irreversível sintomática

Dor espontânea, intensa, pulsátil ou lancinante, que dura de minutos a horas. Piora ao deitar e pode acordar o paciente à noite. A dor permanece depois de remover o estímulo frio ou quente. O paciente muitas vezes não consegue apontar qual dente dói.

Periodontite apical aguda

Dor ao morder e à percussão do dente. O paciente relata a sensação de dente "mais alto" que os outros.

Abscesso apical agudo

Dor intensa e contínua, inchaço localizado na gengiva ou na face, saída de pus e dente muito sensível ao toque. Pode haver febre.

Pericoronarite

Dor, inchaço e mau gosto na região de um dente do siso parcialmente erupcionado. Pode haver dificuldade leve para abrir a boca.

Alveolite (alvéolo seco)

Dor intensa, que irradia para o ouvido, de 2 a 4 dias depois de uma extração. Há mau odor e o alvéolo está sem coágulo.

3. Sinais de alarme: encaminhar ao hospital imediatamente

Encaminhar ao pronto-socorro hospitalar, ou acionar o SAMU (192), quando houver qualquer um destes sinais:

- febre acima de 38,5 °C com mal-estar importante;
- inchaço que se estende para o olho, o pescoço ou o assoalho da boca;
- dificuldade para engolir ou para respirar;
- abertura de boca menor que 2 cm (trismo importante);

- paciente imunossuprimido com sinais de infecção.

Não iniciar procedimento longo nesses casos. Estabilizar e encaminhar.

4. Atendimento passo a passo

Passo 1: Triagem e anamnese

Aferir pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura. Perguntar sobre início e característica da dor, medicamentos em uso, alergias, gravidez, hipertensão, diabetes, uso de anticoagulantes e histórico de endocardite.

Passo 2: Exame clínico

Examinar face e pescoço (assimetria, inchaço, linfonodos, abertura da boca). Examinar a boca (cárie, restaurações, fístula, mobilidade). Fazer teste ao frio, percussão vertical e horizontal, palpação apical e sondagem periodontal.

Passo 3: Radiografia

Solicitar radiografia periapical do dente suspeito. Em gestantes, usar avental plumbífero.

Passo 4: Diagnóstico e conduta imediata

Definir o diagnóstico e executar a conduta indicada na seção 5.

Passo 5: Orientações e retorno

Orientar o paciente, prescrever se necessário e agendar o tratamento definitivo (seção 9).

5. Conduta por diagnóstico

Pulpite reversível

Remover a cárie ou a restauração defeituosa, proteger a polpa e restaurar. Não há indicação de antibiótico.

Pulpite irreversível sintomática

Anestesiar, abrir a câmara pulpar e remover o tecido pulpar (pulpectomia de urgência). Irrigar com hipoclorito de sódio, colocar medicação intracanal com hidróxido de cálcio e selar provisoriamente. Agendar a conclusão do tratamento endodôntico. Antibiótico não é indicado em pulpite sem sinais de infecção sistêmica.

Periodontite apical aguda

Aliviar a oclusão (ajuste oclusal), prescrever analgésico e iniciar o tratamento endodôntico.

Abscesso apical agudo

Drenar (pelo canal ou por incisão) e fazer desbridamento. Prescrever antibiótico somente se houver febre, linfonodos aumentados, inchaço que se espalha ou imunossupressão.

Pericoronarite

Irrigar com solução salina ou clorexidina 0,12% e desbridar sob o opérculo. Avaliar a extração do dente do siso. Antibiótico somente com sinais sistêmicos.

Alveolite

Irrigar o alvéolo com delicadeza e colocar curativo alveolar medicado. Prescrever analgésico. Antibiótico não é rotina.

6. Anestesia local para atendimento de emergência

Anestésico de escolha: lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. Dose máxima de 7 mg/kg, até 500 mg, o que corresponde a cerca de 13 tubetes de 1,8 mL em adulto de 70 kg. Aspirar antes de injetar.

Pacientes hipertensos controlados: limitar a 2 tubetes com vasoconstritor por sessão. Se a pressão estiver igual ou acima de 180/110 mmHg, não realizar procedimento invasivo; em urgência, usar apenas medidas paliativas e encaminhar para avaliação médica.

7. Medicações recomendadas para dor de dente aguda em adultos

Analgésicos

- Paracetamol 500 a 750 mg por via oral a cada 6 a 8 horas. Máximo de 3 g por dia. É a opção preferida para hipertensos e gestantes.
- Dipirona 500 mg a 1 g por via oral a cada 6 a 8 horas. Máximo de 4 g por dia. Não usar se houver alergia a dipirona ou histórico de agranulocitose. Evitar na gestação.

Anti-inflamatório

- Ibuprofeno 400 mg por via oral a cada 6 a 8 horas, por até 3 dias. Máximo de 1.200 mg por dia no uso odontológico.
- Evitar em gestantes, em úlcera ou gastrite, em insuficiência renal e em uso de anticoagulantes.
- Usar com cautela em hipertensos: pode elevar a pressão e reduzir o efeito de anti-hipertensivos como losartana.

Antibióticos (somente com indicação)

- Primeira escolha: amoxicilina 500 mg por via oral a cada 8 horas, por 5 a 7 dias.
- Em infecções mais extensas: associar metronidazol 400 mg a cada 8 horas por 5 a 7 dias. Orientar a não ingerir álcool.
- Pacientes alérgicos à penicilina: azitromicina 500 mg uma vez ao dia por 3 a 5 dias, ou clindamicina 300 mg a cada 6 horas por 5 a 7 dias (atenção a diarreia persistente).

Antisséptico bucal

- Clorexidina 0,12%, 15 mL, bochecho por 30 segundos, duas vezes ao dia, por 7 dias.

Dor intensa que não cede

Reavaliar o diagnóstico. Opioide fraco apenas sob prescrição e a critério do cirurgião-dentista responsável; não é conduta de rotina.

8. Condições especiais

- **Hipertensos:** preferir paracetamol; evitar ou limitar anti-inflamatórios; limitar o vasoconstritor a 2 tubetes.
- **Gestantes:** preferir paracetamol; evitar anti-inflamatórios; lidocaína com epinefrina é considerada segura; evitar anestésico com felipressina; amoxicilina é a opção de antibiótico quando indicado.
- **Diabéticos:** agendar pela manhã, depois da refeição; infecção pode descompensar a glicemia.
- **Anticoagulados:** não suspender o anticoagulante sem orientação do médico; usar hemostasia local.

- **Alérgicos à penicilina:** usar azitromicina ou clindamicina quando houver indicação de antibiótico.
- **Crianças:** doses calculadas por peso; discutir com o odontopediatra. Nunca usar dose de adulto.

9. Orientações ao paciente e retorno

- Tomar a medicação nos horários prescritos e não esperar a dor ficar forte.
- Evitar mastigar do lado do dente tratado até concluir o tratamento.
- Retornar em 24 a 72 horas se a dor persistir, e em até 7 dias para o tratamento definitivo.
- Procurar atendimento imediato se surgirem febre, inchaço crescente, dificuldade para engolir ou para respirar.

10. Registro em prontuário

Registrar queixa, pressão arterial, alergias, diagnóstico, procedimento realizado, medicação prescrita, orientações e data de retorno.